Centro Universitário de Brasília – CEUB
Diretoria de Educação a Distância – DIREAD
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

PEDRO PAULO BASTA – RA: 72501187

ATIVIDADE AVALIATIVA 01

PLANEJAMENTO DO PROJETO INTEGRADOR DE TI
Saúde Plena – Sistema Web de Agendamento e Prontuário para Atendimento Psicológico

Brasília – DF
2026

SAÚDE PLENA – SISTEMA WEB DE AGENDAMENTO E PRONTUÁRIO PARA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO

Trabalho apresentado como Atividade Avaliativa 01 da disciplina Projeto Integrador de TI, ministrada pelo Prof. Daniel Barbosa Santos, desenvolvido como Atividade Curricular de Extensão (ACE).

Brasília – DF
2026

RESUMO

Este documento apresenta o planejamento de um projeto de extensão que visa desenvolver um sistema web de agendamento e prontuário para uma psicóloga autônoma do Distrito Federal. O projeto evolui o Sistema de Agendamento da Clínica Saúde Plena, desenvolvido anteriormente pelo autor, adaptando-o a uma demanda real: organizar a agenda, reduzir faltas, controlar pagamentos e proteger os registros de atendimento psicológico, que são dados pessoais sensíveis. São apresentados o Termo de Abertura do Projeto, com justificativa, objetivos, escopo, partes interessadas, restrições, cronograma, orçamento, premissas e critérios de sucesso; a Estrutura Analítica do Projeto e seu dicionário; a matriz de riscos com as estratégias de resposta; e as tecnologias adotadas. A solução prevê backend em Node.js com Express, banco de dados PostgreSQL, autenticação, criptografia e backup automatizado, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e com as normas do Conselho Federal de Psicologia.

Palavras-chave: gerenciamento de projetos; extensão universitária; sistema de agendamento; prontuário psicológico; LGPD.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 1

2 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO 2

2.1 Identificação do Projeto 2

2.2 Justificativa do Projeto 2

2.3 Objetivos do Projeto 2

2.4 Escopo do Projeto 3

2.5 Principais Partes Interessadas (Stakeholders) 3

2.6 Riscos do Projeto 4

2.7 Restrições do Projeto 4

2.8 Visão Geral do Cronograma 4

2.9 Visão Geral do Orçamento 5

2.10 Designação do Gerente de Projeto e Responsabilidades 5

2.11 Premissas do Projeto 5

2.12 Critérios de Sucesso do Projeto 6

3 ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP) 7

3.1 EAP 7

3.2 Dicionário da EAP 7

4 GESTÃO DE RISCOS 9

4.1 Metodologia 9

4.2 Matriz de Riscos 9

4.3 Estratégias de Mitigação dos Riscos 10

5 TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS 11

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 12

REFERÊNCIAS 13

1 INTRODUÇÃO

Este documento reúne as entregas da Atividade Avaliativa 01 da disciplina Projeto Integrador de TI: o Termo de Abertura do Projeto, a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e seu dicionário, a gestão de riscos e as tecnologias adotadas. O projeto é desenvolvido como Atividade Curricular de Extensão (ACE), em parceria com a psicóloga autônoma Beatriz Xavier, representante da comunidade externa.

A proposta evolui o Sistema de Agendamento da Clínica Saúde Plena, especificado anteriormente pelo autor na disciplina Engenharia e Projeto de Software. Aquela versão atendia a uma clínica multiprofissional fictícia, com autoatendimento do paciente, sem autenticação e com persistência em arquivos JSON. A aplicação a um caso real exigiu três mudanças de fundo: o foco passa a ser uma única profissional de psicologia; o sistema passa a registrar a evolução das sessões, que é dado pessoal sensível nos termos do art. 11 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD); e a persistência migra para banco de dados relacional (PostgreSQL), com autenticação, controle de acesso, criptografia e backup. A lógica de agendamento, a validação de CPF, a prevenção de conflito de horários e a interface web já construídas serão reaproveitadas.

2 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

2.1 Identificação do Projeto

Tabela 1 – Identificação do projeto

Campo	Descrição
Nome do projeto	Saúde Plena – Sistema Web de Agendamento e Prontuário para Atendimento Psicológico
Parceira (comunidade externa)	Beatriz Xavier – psicóloga autônoma (Pessoa Física)
Gerente do projeto	Pedro Paulo Basta – RA 72501187
Curso / Instituição	CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – CEUB
Disciplina / Docente	Projeto Integrador de TI – Prof. Daniel Barbosa Santos
Período	2º semestre de 2026
Natureza	Atividade Curricular de Extensão (ACE)

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

2.2 Justificativa do Projeto

Atualmente, a parceira gerencia sua agenda por meio de mensagens de WhatsApp e de uma agenda de papel, e registra a evolução das sessões em fichas físicas. O controle de pagamentos é feito manualmente.s Esse modelo gera conflitos e esquecimentos de horários, faltas sem aviso prévio (com perda de receita), dificuldade em saber quais sessões foram pagas e esforço administrativo que reduz o tempo dedicado aos atendimentos.

Há ainda uma dimensão regulatória. Os registros de atendimento psicológico são dados sensíveis pela LGPD e devem ser guardados por, no mínimo, cinco anos, conforme a Resolução CFP nº 001/2009. Fichas em papel e arquivos soltos não oferecem controle de acesso, rastreabilidade nem cópia de segurança. Soluções comerciais existem, mas impõem custo mensal recorrente, oferecem funcionalidades genéricas que não refletem a rotina da parceira e mantêm os dados dos pacientes sob controle de terceiros. Um sistema web simples, seguro e de baixo custo atende, portanto, a uma demanda real e tem impacto social direto, que é o propósito da extensão universitária.

2.3 Objetivos do Projeto

Objetivo geral: desenvolver e implantar um sistema web que centralize a agenda, o cadastro de pacientes, o registro de sessões e o controle de pagamentos

da parceira, de forma segura e aderente à LGPD e às normas do Conselho Federal de Psicologia.

Objetivos específicos:

- Eliminar conflitos de horário por meio de bloqueio automático de agendamentos sobrepostos;
- Permitir marcar, remarcar ou cancelar uma sessão em menos de um minuto;
- Restringir o acesso aos registros de sessão exclusivamente à psicóloga, mediante autenticação e criptografia;
- Reduzir faltas por meio de lembretes automáticos por e-mail enviados com antecedência;
- Gerar relatório mensal de sessões realizadas, faltas e valores recebidos;
- Garantir backup automático e testado dos dados.

2.4 Escopo do Projeto

Incluído no escopo:

- Autenticação da profissional com senha forte e sessão segura;
- Cadastro de pacientes (dados de identificação e contato, com validação de CPF);
- Agenda em visão de calendário: marcação, remarcação, cancelamento e registro de falta, com prevenção de conflito;
- Registro da evolução por sessão, com acesso restrito e criptografia do conteúdo;
- Controle financeiro simples: valor por sessão, situação de pagamento e forma de pagamento;
- Relatórios mensais de atendimentos, faltas e recebimentos;
- Lembrete de sessão por e-mail ao paciente;
- Modelo de termo de consentimento para tratamento de dados (LGPD);
- Rotina de backup automático, implantação em ambiente de hospedagem, manual do usuário e treinamento da parceira.

Fora do escopo: teleconsulta ou chamadas de vídeo; emissão de nota fiscal ou recibo fiscal; integração com convênios e operadoras de saúde; aplicativo móvel nativo (o sistema será responsivo); envio automatizado por WhatsApp, cuja API

oficial é paga; e acesso do paciente ao sistema. Este último item foi retirado em relação à versão original da Clínica Saúde Plena para reduzir a superfície de exposição dos dados sensíveis.

2.5 Principais Partes Interessadas (Stakeholders)

Tabela 2 – Partes interessadas

Parte interessada	Papel no projeto	Interesses / expectativas
Beatriz Xavier	Parceira e usuária final	Organização da agenda, sigilo dos registros, economia de tempo, custo baixo
Pacientes da parceira	Titulares dos dados	Sigilo, lembretes confiáveis, respeito aos direitos da LGPD
Pedro Paulo Basta	Gerente e desenvolvedor	Entregar a solução no prazo e obter aprovação na disciplina
Prof. Daniel Barbosa Santos	Orientador e avaliador	Qualidade técnica, cumprimento das etapas e da ACE
CEUB	Instituição de ensino	Extensão com impacto social comprovado

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

2.6 Riscos do Projeto

Os principais riscos identificados na abertura são: acesso indevido ou vazamento de dados sensíveis; não conformidade com a LGPD e com as normas do CFP; perda de dados; atraso por sobrecarga do desenvolvedor; indisponibilidade da parceira para reuniões e validações; aumento descontrolado do escopo; limitações dos planos gratuitos de hospedagem; requisitos mal compreendidos; e baixa adesão da usuária ao sistema. A análise detalhada, com matriz de probabilidade e impacto e estratégias de resposta, está no capítulo 4.

2.7 Restrições do Projeto

- **Prazo:** o projeto deve ser concluído dentro do 2º semestre letivo de 2026, conforme o calendário da disciplina;
- **Orçamento:** desembolso praticamente nulo, com uso preferencial de planos gratuitos de hospedagem e serviços;
- **Equipe:** um único desenvolvedor, que concilia o projeto com atividade profissional e outras disciplinas;
- **Legal e ética:** obrigatoriedade de atender à LGPD (Lei nº 13.709/2018) e à Resolução CFP nº 001/2009;

- **Tecnológica:** reaproveitamento da base Node.js/Express da Clínica Saúde Plena.

2.8 Visão Geral do Cronograma

Tabela 3 – Cronograma macro do projeto

Fase	Período previsto	Marco / entregável
1. Iniciação e planejamento	28/09 a 18/10/2026	Atividade Avaliativa 01 e Termo de Anuência assinado
2. Levantamento de requisitos	19/10 a 25/10/2026	ERS atualizada e validada pela parceira
3. Projeto da solução	26/10 a 01/11/2026	Modelo de dados, arquitetura e protótipos aprovados
4. Desenvolvimento	02/11 a 22/11/2026	Versão funcional com todos os módulos
5. Testes e aceitação	23/11 a 29/11/2026	Relatório de testes e aceite da parceira
6. Implantação e encerramento	30/11 a 06/12/2026	Sistema em produção, treinamento e relatório final

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

2.9 Visão Geral do Orçamento

Por se tratar de projeto de extensão, não há cobrança à parceira. Os custos previstos restringem-se à infraestrutura; o esforço de desenvolvimento é apresentado apenas como valor de referência do serviço entregue.

Tabela 4 – Estimativa orçamentária

Item	Solução prevista	Custo estimado
Hospedagem da aplicação	Render – plano gratuito	R$ 0,00
Banco de dados	PostgreSQL gerenciado (Supabase – plano gratuito, região São Paulo)	R$ 0,00
Envio de e-mails	Brevo – plano gratuito	R$ 0,00
Domínio próprio (opcional)	Registro .com.br	R$ 40,00/ano
Reserva de contingência	Migração para plano pago, se o gratuito se mostrar insuficiente	até R$ 50,00/mês
Esforço de desenvolvimento (referência)	134 h × R$ 50,00/h (não cobrado – ACE)	R$ 6.700,00
Desembolso previsto		**R$ 0,00 a R$ 40,00**

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

2.10 Designação do Gerente de Projeto e Responsabilidades

Fica designado como gerente do projeto o estudante **Pedro Paulo Basta** (RA 72501187), que acumula também as funções de analista e desenvolvedor. São suas responsabilidades:

- Conduzir o levantamento de requisitos e as reuniões de validação com a parceira;

- Planejar e controlar escopo, prazo, custos e riscos;
- Projetar, desenvolver, testar e implantar a solução;
- Garantir a conformidade do sistema com a LGPD e com as normas do CFP;
- Comunicar o andamento ao docente e registrar as entregas de cada etapa;
- Treinar a usuária, entregar a documentação e conduzir o encerramento do projeto.

2.11 Premissas do Projeto

- A parceira estará disponível para, no mínimo, três encontros: levantamento de requisitos, validação e treinamento;
- A parceira dispõe de computador ou celular com acesso à internet;
- Os planos gratuitos dos serviços de hospedagem permanecerão disponíveis durante o semestre;
- O código da Clínica Saúde Plena pode ser reaproveitado como base do novo sistema;
- Os pacientes que receberão lembretes por e-mail consentirão com o tratamento de seus dados.

2.12 Critérios de Sucesso do Projeto

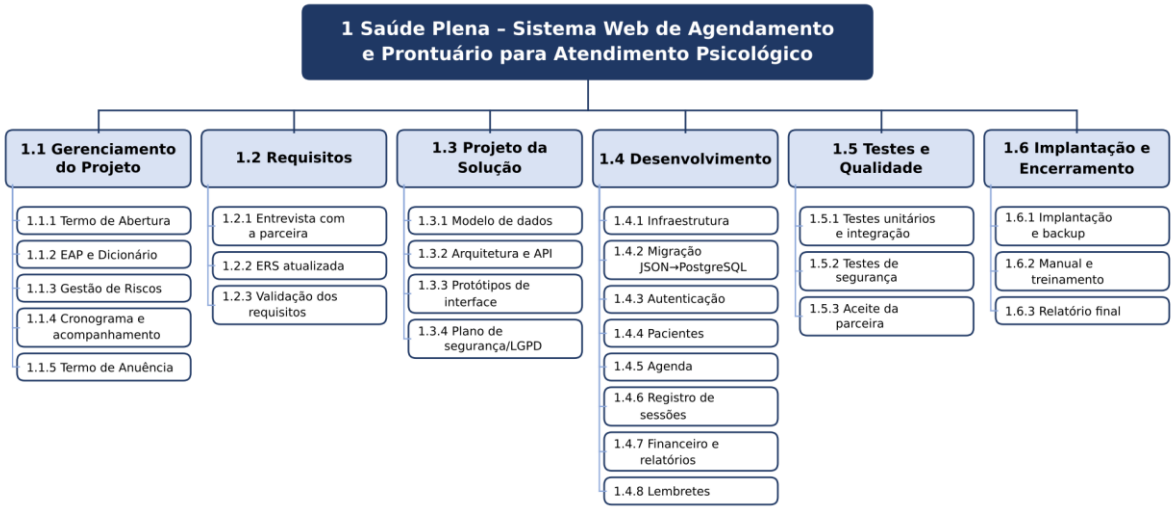
- Sistema implantado e em uso real pela parceira até o encerramento do semestre;
- 100% dos requisitos do escopo entregues e aceitos formalmente pela parceira;
- Nenhum acesso não autenticado aos registros de sessão nos testes de segurança;
- Restauração de backup testada com sucesso antes da implantação;
- Avaliação de satisfação da parceira igual ou superior a 4, em escala de 1 a 5;
- Documentação aprovada pelo docente da disciplina.

3 ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

3.1 EAP

A EAP foi decomposta por fases do ciclo de vida, em três níveis, até os pacotes de trabalho. A Figura 1 apresenta a estrutura hierárquica.

Figura 1 – Estrutura Analítica do Projeto



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

3.2 Dicionário da EAP

O dicionário descreve cada pacote de trabalho, o entregável correspondente, o critério de aceitação e a estimativa de esforço. Todos os pacotes têm como responsável o gerente do projeto; a parceira participa dos pacotes 1.2.1, 1.2.3, 1.5.3 e 1.6.2.

Tabela 5 – Dicionário da EAP

Código	Pacote de trabalho	Descrição / entregável	Critério de aceitação	Esforço (h)
1.1	**Gerenciamento do Projeto**			
1.1.1	Termo de Abertura	Documento que formaliza justificativa, objetivos, escopo, partes interessadas e restrições.	Aprovado na Atividade 01	4
1.1.2	EAP e Dicionário	Decomposição hierárquica do trabalho e descrição dos pacotes.	Todos os entregáveis do escopo cobertos	4
1.1.3	Gestão de Riscos	Matriz de probabilidade × impacto e plano de resposta.	Riscos com estratégia e responsável	3
1.1.4	Cronograma e acompanhamento	Cronograma detalhado e quadro Kanban atualizado semanalmente.	Quadro atualizado a cada semana	4

Código	Pacote de trabalho	Descrição / entregável	Critério de aceitação	Esforço (h)
1.1.5	Termo de Anuência	Termo de Anuência de ACE assinado pela parceira.	Termo assinado e entregue	1
1.2	**Requisitos**			
1.2.1	Entrevista com a parceira	Reunião para mapear o processo atual e as necessidades.	Ata registrada	3
1.2.2	ERS atualizada	Especificação de requisitos funcionais, não funcionais e de dados para o novo contexto.	Requisitos testáveis e rastreáveis	5
1.2.3	Validação dos requisitos	Revisão da ERS com a parceira.	Aceite formal da parceira	2
1.3	**Projeto da Solução**			
1.3.1	Modelo de dados	Diagrama entidade-relacionamento e script de criação no PostgreSQL.	Modelo normalizado (3FN)	5
1.3.2	Arquitetura e API	Definição das camadas e dos endpoints REST.	Endpoints documentados	4
1.3.3	Protótipos de interface	Telas de login, agenda, pacientes, sessão e relatórios.	Protótipos aprovados pela parceira	6
1.3.4	Plano de segurança e LGPD	Controles de acesso, criptografia, retenção e termo de consentimento.	Controles mapeados aos requisitos	4
1.4	**Desenvolvimento**			
1.4.1	Infraestrutura	Repositório, ambiente Docker, banco, pipeline de CI e deploy.	Deploy automático funcionando	5
1.4.2	Migração JSON → PostgreSQL	Adaptação da base da Clínica Saúde Plena para o banco relacional via ORM.	Funções originais operando no banco	6
1.4.3	Autenticação	Login, hash de senha, sessão segura e bloqueio por tentativas.	Rotas protegidas; testes aprovados	8
1.4.4	Pacientes	CRUD de pacientes com validação de CPF.	CRUD completo e validado	6
1.4.5	Agenda	Calendário, marcação, remarcação, cancelamento, faltas e prevenção de conflito.	Nenhum conflito possível nos testes	12
1.4.6	Registro de sessões	Evolução por sessão com criptografia e acesso restrito.	Conteúdo cifrado no banco	10
1.4.7	Financeiro e relatórios	Situação de pagamento por sessão e relatório mensal.	Totais conferidos com dados de teste	8
1.4.8	Lembretes	Envio automático de e-mail antes da sessão.	E-mail recebido no prazo configurado	5
1.5	**Testes e Qualidade**			
1.5.1	Testes unitários e de integração	Testes automatizados das regras de negócio e da API.	Cobertura mínima de 70% nas regras	8
1.5.2	Testes de segurança	Verificação dos riscos OWASP Top 10 e varredura automatizada.	Nenhuma vulnerabilidade alta aberta	5
1.5.3	Aceite da parceira	Teste de aceitação com roteiro de uso real.	Termo de aceite assinado	3
1.6	**Implantação e Encerramento**			
1.6.1	Implantação e backup	Publicação em produção e rotina de backup com teste de restauração.	Sistema no ar; restauração testada	4
1.6.2	Manual e treinamento	Manual ilustrado e sessão de treinamento com a parceira.	Parceira opera o sistema sozinha	5

Código	Pacote de trabalho	Descrição / entregável	Critério de aceitação	Esforço (h)
1.6.3	Relatório final	Relatório de encerramento e lições aprendidas.	Entregue ao docente	4
	Total estimado			**134**

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

4 GESTÃO DE RISCOS

4.1 Metodologia

Os riscos foram avaliados de forma qualitativa, atribuindo-se probabilidade (P) e impacto (I) em escala de 1 (muito baixo) a 5 (muito alto). A exposição é o produto P × I e define o nível: **baixo** (1 a 4), **médio** (5 a 9), **alto** (10 a 16) e **crítico** (20 a 25). As estratégias de resposta seguem a classificação do PMBOK: evitar, mitigar, transferir ou aceitar.

4.2 Matriz de Riscos

Tabela 6 – Matriz de riscos (ordenada por exposição)

ID	Risco	Categoria	P	I	P×I	Nível
R04	Atraso por sobrecarga do desenvolvedor (trabalho e outras disciplinas)	Cronograma	4	4	16	Alto
R05	Indisponibilidade da parceira para reuniões e validações	Partes interessadas	3	4	12	Alto
R01	Acesso indevido ou vazamento de dados sensíveis dos pacientes	Segurança	2	5	10	Alto
R02	Não conformidade com a LGPD e com a Resolução CFP nº 001/2009	Legal	2	5	10	Alto
R03	Perda de dados por falha da hospedagem ou exclusão acidental	Técnico	2	5	10	Alto
R06	Aumento de escopo (WhatsApp, nota fiscal, teleconsulta)	Escopo	3	3	9	Médio
R07	Limitações dos planos gratuitos (suspensão por inatividade, lentidão, mudança de termos)	Técnico	3	3	9	Médio
R08	Requisitos mal compreendidos ou incompletos	Requisitos	3	3	9	Médio
R09	Baixa adesão da usuária ao sistema	Adoção	2	4	8	Médio
R10	Dificuldades técnicas na migração de JSON para PostgreSQL	Técnico	2	3	6	Médio
R11	Lembretes classificados como spam ou não entregues	Técnico	3	2	6	Médio

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A Tabela 7 posiciona os riscos no mapa de calor de probabilidade × impacto.

Tabela 7 – Mapa de calor de probabilidade × impacto

	I = 1	I = 2	I = 3	I = 4	I = 5
P = 5					
P = 4				R04	
P = 3		R11	R06, R07, R08	R05	
P = 2			R10	R09	R01, R02, R03
P = 1					

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

4.3 Estratégias de Mitigação dos Riscos

Tabela 8 – Plano de resposta aos riscos

ID	Estratégia	Ações de resposta	Gatilho
R04	Mitigar	Cronograma com folga; metas semanais no Kanban; priorização MoSCoW, entregando primeiro agenda, pacientes e autenticação.	Duas semanas seguidas abaixo da meta
R05	Mitigar	Agendar todos os encontros na primeira reunião; validações assíncronas por vídeo curto ou protótipo navegável.	Reunião remarcada mais de uma vez
R01	Mitigar	Senhas com bcrypt; sessão em cookie HttpOnly/Secure; HTTPS; criptografia AES-256-GCM dos registros; limite de tentativas de login; testes OWASP.	Alerta da varredura ou acesso anômalo no log
R02	Evitar	Termo de consentimento; coleta mínima de dados; banco hospedado no Brasil; política de retenção de 5 anos; revisão do checklist LGPD antes da implantação.	Item do checklist LGPD não atendido
R03	Mitigar	Backup diário automatizado (pg_dump) criptografado e fora do provedor do banco; teste de restauração antes da implantação.	Falha na rotina de backup
R06	Evitar	Escopo e itens excluídos formalizados no Termo de Abertura; novas demandas registradas como melhorias futuras.	Pedido fora do escopo
R07	Mitigar / aceitar	Rotina que mantém o banco ativo; reserva de contingência para plano pago; aplicação em Docker, portável entre provedores.	Suspensão ou lentidão do serviço
R08	Mitigar	Prototipação antes do código; validação formal da ERS; ciclos curtos de demonstração.	Divergência na validação
R09	Mitigar	Interface simples, testada com a usuária desde o protótipo; manual ilustrado e treinamento prático.	Uso irregular após a implantação
R10	Mitigar	Uso de ORM com migrações versionadas; migração incremental, módulo a módulo, com testes.	Teste de regressão falhando
R11	Mitigar / aceitar	Serviço SMTP transacional com domínio autenticado (SPF/DKIM); lembrete manual como contingência.	Paciente relata não ter recebido

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Todos os riscos têm como responsável o gerente do projeto e serão revisados semanalmente durante o acompanhamento do cronograma (pacote 1.1.4).

5 TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS

A seleção priorizou o reaproveitamento da base existente, o custo zero, a maturidade das ferramentas e os requisitos de segurança impostos pelos dados sensíveis.

Tabela 9 – Soluções tecnológicas adotadas

Categoria	Tecnologia	Finalidade no projeto	Justificativa
Frontend	HTML5, CSS3 e JavaScript (ES6+)	Interface responsiva	Reaproveita a interface da Clínica Saúde Plena, sem etapa de build
Frontend	FullCalendar	Visualização e interação com a agenda	Biblioteca madura e de código aberto para calendários
Backend	Node.js (LTS) e Express	API REST e regras de negócio	Base já desenvolvida; ecossistema amplo
Banco de dados	PostgreSQL (Supabase, região São Paulo)	Persistência relacional	Integridade referencial, transações e restrições que impedem conflitos; dados mantidos no Brasil
Acesso a dados	Prisma ORM	Modelagem, consultas e migrações	Migrações versionadas e proteção contra SQL Injection
Autenticação	bcrypt, express-session e connect-pg-simple	Login e sessão segura	Hash de senha robusto; sessão em cookie HttpOnly persistida no banco
Segurança	Helmet, express-rate-limit, Zod e módulo crypto (AES-256-GCM)	Cabeçalhos, limite de tentativas, validação e criptografia	Mitiga riscos do OWASP Top 10 e protege os registros de sessão
Notificações	Nodemailer e Brevo (SMTP)	Lembretes por e-mail	Plano gratuito compatível com o volume esperado
Testes	Jest, Supertest e OWASP ZAP	Testes unitários, de integração e de segurança	Automação e varredura de vulnerabilidades
Versionamento e CI	Git, GitHub e GitHub Actions	Controle de versão, testes e backup agendados	Gratuito e integrado ao repositório
Ambiente	Docker	Padronização do ambiente de execução	Portabilidade entre provedores, prevista na ERS anterior
Hospedagem	Render	Publicação da aplicação com HTTPS	Plano gratuito com deploy a partir do GitHub
Modelagem e prototipação	Figma e dbdiagram.io	Protótipos de tela e diagrama do banco	Gratuitos e fáceis de compartilhar com a parceira
Gestão do projeto	GitHub Projects (Kanban)	Acompanhamento das tarefas	Integrado ao repositório e às issues

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O planejamento apresentado transforma um projeto acadêmico prévio em uma solução para uma demanda real da comunidade. A principal mudança em relação à versão original é a centralidade da proteção de dados: como o sistema tratará registros de atendimento psicológico, segurança e conformidade legal deixam de ser requisitos acessórios e passam a orientar o escopo, a arquitetura e a gestão de riscos. As próximas etapas são o levantamento detalhado de requisitos com a parceira e o projeto da solução.

REFERÊNCIAS

BASTA, Pedro Paulo. **Especificação de requisitos de software:** Sistema de Agendamento de Consultas e Exames – Clínica Saúde Plena. Trabalho da disciplina Engenharia e Projeto de Software. Brasília: CEUB, 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (Brasil). **Resolução CFP nº 001/2009**. Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro documental decorrente da prestação de serviços psicológicos. Brasília: CFP, 2009.

OWASP FOUNDATION. **OWASP Top 10:2021**. [S. l.]: OWASP, 2021. Disponível em: https://owasp.org/Top10/. Acesso em: 18 out. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK)**. 7. ed. Newtown Square: PMI, 2021.